2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

ENTRE A INSEGURANÇA E A AUTONOMIA: A EXPERIÊNCIA FORMATIVA NO MODELO OMBRO A OMBRO EM UMA UBS URBANA

Autores e Vínculo: AGDA ROSE BEZERRA ALVES AQUINO[1], HUDSON RENAN COSTA SILVA[1], MARYANNE MARIA SIMPLICIO SANTOS[2], VINICIUS TENÓRIO COSTA VIEIRA[2], BÁRBARA ROSE BEZERRA ALVES FERREIRA[3].
[1] Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, Centro Universitário CESMAC, Maceió-AL, Brasil.
[2] Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, Arapiraca-AL, Brasil.
[3] Programa de Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia, Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Maceió-AL, Brasil.

Imagens 1 e 2: visita domiciliar realizada na modalidade ombro a ombro e discussão científica teórica com preceptor.

AUTONOMIA É PROCESSO, NÃO PONTO DE PARTIDA

O início da residência como ponto de partida para o desenvolvimento clínico, guiado por supervisão direta que transforma prática em competência.

Introdução

Entre abril e julho, uma residente do primeiro ano de Medicina de Família e Comunidade vivenciou a modalidade “ombro a ombro” em uma Unidade Básica de Saúde urbana vinculada à Estratégia Saúde da Família. A equipe era composta por médico preceptor, enfermeira, cirurgiã-dentista, equipe de saúde bucal e nove agentes comunitários de saúde, em cenário marcado por alta demanda assistencial e predominância de condições agudas.

Objetivos

O período inicial da residência foi atravessado por insegurança clínica, intensificada pela necessidade de resolutividade frente a lista extensa de garantia de acesso.

Métodos

A atuação alternou atendimentos compartilhados e individuais supervisionados, com discussão sistemática das condutas antes da finalização, além de visitas domiciliares semanais, reuniões de equipe e participação em grupo de gestantes.

Resultados

O modelo de supervisão direta mostrou-se dispositivo pedagógico potente, favorecendo ampliação do raciocínio clínico, tomada de decisão segura e construção progressiva da autonomia. Em consonância com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e do Ministério da Saúde para a formação na Atenção Primária à Saúde, a experiência evidenciou que a autonomia se constrói de modo gradual, mediada por supervisão qualificada e inserção territorial.

Conclusão/Considerações finais

A vivência reafirma a APS como espaço privilegiado de formação, no qual ensino e cuidado se articulam, revelando sua potência transformadora na construção da identidade profissional.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MFC, CESMAC, BRASIL
AGDA ROSE BEZERRA ALVES AQUINO
MÉDICA RESIDENTE EM MFC

E-mail: agdarosealves@gmail.com
Contatos: 82999606558

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DE ARAPIRACA/AL
CESMAC